

外感发热病的辨证论治

本院中医基本理论教研组

外感发热病,是指外感六淫之邪而引起发热等证候及其变化的疾病(包括大部分急性传染病在内的发热性流行性疾病)的总称。

对于外感发热病的诊治,过去有两种学说——伤寒学说、温病学说。这两种学说所讨论的治疗对象,同是外感发热病,只不过伤寒学说强调外感寒邪,详于治“寒化”之证;温病学说认为外感以温热发病为多,故详于治“热化”之证。从历史唯物主义观点来看,温病学说是伤寒学说的继续和发展。今天应以一分为二的观点,对两者的经验和理论,继续加以整理、总结和发扬。

关于外感发热病的致病原因,由于前人没有显微镜的帮助,没有微生物学,对致病物质不可能有具体的认识,只有“六淫”、“疠气”、“杂气”的概念。中医主要通过对人体与外界环境关系的观察,发现气候变化与季节性疾病有一定的规律,认为冬季有伤寒病,春季有风温病和春温病;夏季有暑温和湿温病;秋季有秋燥和伏暑病等。故认为六淫是外感发热病的致病原因,并特别强调六淫之邪所以能致人于病,是通过人体“正气不足以拒邪”这个变化的根据而发病的。并且认为,反常的气候往往是产生疫病等流行病的一个重要条件。今天看来,除了认识每种传染病的病原体,并通过实验方法以确诊各种传染病之外,还应重视气候对疾病的影响及个体的反应。例如同是乙型脑炎患者,往往由于当时气候不同,引起人体不同的反应,因而在治疗方面,有相当大的差别,这是值得重视的。

关于外感发热病的病理,伤寒学说与温病学说的论述不同。伤寒学说认为寒邪可沿着六

经传变,并以六经来分证。外感发病初期,患者正气未衰,邪犯足太阳膀胱经,正气拒邪于外,故见恶寒、发热等证;病进一步发展,犯及足少阳胆经,邪在半表半里而证见寒热往来;若寒邪化热入里,犯及足阳明胃经,便见高热,大便燥结等阳明经证候。以上为三阳病,属于实证、热证。若疾病继续发展,患者正气虚衰,便可能出现泄泻、腹痛、吐蛔、四肢厥逆、下利清谷等太阴、少阴、厥阴等三阴病证。三阴病多属虚证、寒证。

温病学说对病理过程有两种见解:

1.三焦说:认为病邪从口鼻而入,首先犯肺,肺合皮毛而见恶风寒、发热等证。若邪热过盛,可能逆传心包而出现神昏谵语等证。以上属上焦病。若热盛不逆传心包而顺传入中焦胃肠,便见高热便秘等证。若中焦未愈,再进入下焦,热伤肝肾阴津而见身热神倦、肢厥、心悸等证。

2.卫气营血说:认为病邪从皮肤或口鼻而入,病初发,邪在皮肤,故发恶风寒;若邪从口鼻而入则邪犯肺经,证见发热、咳嗽等症,称为“卫分病”。病邪进一步发展,热盛入里,犯及肠胃、气分,便见高热及其他实证,称为“气分病”。高热不退,邪热内盛,影响心营,便见神昏谵语等脑症状,称为“营分病”。营热不退,损伤津血,则见瘀斑出血等症状,称为“血分病”。

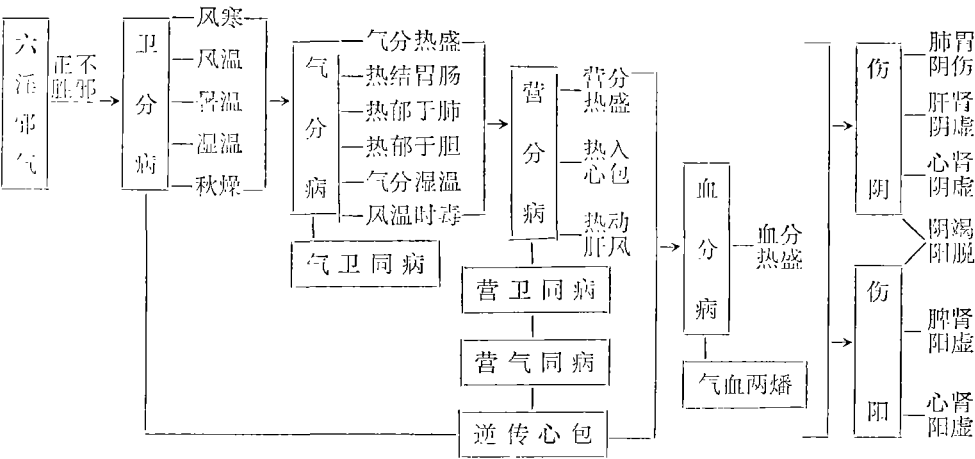
上述伤寒、温病等学说虽然名称各异,但也有相同的基本观点——外感热病的病理过程,是病邪由表入里的过程。但不论寒邪、温邪,入里都从热化而出现胃肠实热证,故六经说的“阳明病”与卫气营血说的“气分病”及

三焦说的“中焦”基本相同。所不同者，在于寒邪易于伤阳，也可以直中三阴经；温邪易于伤阴，也有伏热在里之证。伤寒三阴经病多属阳气虚衰之证，温病的下焦病与营分、血分病多属阴液损伤之证。

实践是检验真理的标准。通过临床实践来验证，上述三种学说的辨证方法有同有异，各

有短长而又可互相补充，我们把它统一起来，以卫气营血为纲，补充伤阴、伤阳两类辨证内容，基本可以概括整个外感发热病的过程。由于“六经”还涉及到一些误治变证和脏腑杂病，故另列附录，以供参考。

根据临床观察，外感发热病的病理过程可归纳如下表：



从上表可以看出：外感发热的病理过程，一般从卫分开始，传入气分，渐次传入营分，血分，最后损害人身的真阴、真阳。但由于病邪的类别不同，病人体质反应不同，病理变化有所不同。如有的患者卫分病出现不久，未见气分证，已出现营分证，而有神志模糊的症状者，名为“逆传心包”。有的邪已传入营、血，而气分或卫分病的证候仍在的，称为“营卫同病、气血两燔”。或邪已入营，经过治疗，转出气分的称为“透营转气”。亦有疾病初起，即从气分或营分开始，而无卫分的证候的，称为“伏气”，如伏暑、春温之类。

总之外感发热病的病理过程，是一个复杂多变的过程。但在复杂的过程中，亦有其一定的规律，既有一般的规律，亦有特殊的规律。过细地辨证，便能掌握其规律。

关于外感发热病的辨证，首先辨别病邪在卫、气、营、血与伤阴、伤阳。邪在卫分以

恶风寒、发热、苔薄、脉浮为主证，并注意发病的季节并鉴别其偏寒、偏温。病在气分以高热、口渴、便秘、苔黄、脉洪数或沉实为主证，并注意辨别是否为胆、肺热郁或湿温里证。病已及营，舌质多绛，精神烦躁，甚至谵语神昏，脉多细数。热入血分，热盛迫血，故出现各种出血症状，精神躁扰不安，甚至昏迷或发狂，舌质深绛。若肝肾阴伤，身热不退，神倦肢怠，甚至汗出虚脱，必舌绛苔少，甚至无苔，脉虚数或虚大，若阳虚欲脱，则见但欲寐或躁烦、肢厥、脉微欲绝。

凡持续高热不退或昏睡不醒、大出血不止、呼吸微弱不整、脉微欲绝等均属危重证候。

外感发热病的治法，邪在卫分，用解表法，可根据风、寒、暑、湿、燥，选用辛凉、辛温、解暑、化湿、润燥等法。病在气分，用清气法或通下法。可根据热的轻重，在上在

下,所在脏腑,选用方剂。总之,热能伤津,应注意保存阴津为主。若属湿温,应根据湿与热的孰重孰轻,选用芳香化浊,或辛开苦降,或寒凉清热,或淡渗利湿等法。病在营分用清营泄热法,若神识不清或神昏谵语,可结合开窍通神。若病已入血,便须凉血散血,出血严重者,须配合止血益气之剂。若热毒炽盛,内外俱热,病势急骤,应大剂清热解毒。若肝肾阴伤,宜滋养肝肾。若肝风内动,实证用清热镇肝息风,虚证用滋肾养肝。若阳虚欲脱,应回阳救逆。

第一节 卫分病证治

卫是外卫的意思。卫主一身的表层,内合于肺。卫分病即指外感病初期阶段,肌表受邪气侵袭,卫外调节机能失常而出现的病变,包括太阳经的病变。临床表现为发热、恶风寒、头痛、苔薄白、脉浮。或出现鼻塞、咳嗽等上呼吸道(肺经)症状,称为外感“表证”。以发热而恶风寒为特征。根据季节、病因的不同,区分为风寒、风温、暑温、湿温、秋燥等几种表证类型。

卫分病治疗原则,以解表透邪为主。卫分病未解,可传入气分或逆传心包。

一、风寒表证

主证:头痛,恶寒,发热,无汗或微汗,身体骨节疼痛,舌色正常,苔薄白,脉浮紧或浮缓。

分析:风寒外束,体表卫分受寒邪影响,故有比较明显的恶寒症状。血脉经络阻滞,故身体骨节疼痛。头为诸阳之会,寒邪外束,阳气失去正常流通,故见头痛。风寒外袭,卫气起而抗拒,故身热而脉浮。寒则收缩,汗孔紧闭,故无汗;若卫气受伤,腠理疏松,则见微汗出。脉浮紧,多与无汗并见,是由于外寒盛,属表实证;脉浮缓则常与微汗出并见,是因卫气虚,属表虚证。舌色正常,表示里未受邪。

治则:辛温解表。

方药:麻黄汤、桂枝汤、荆防败毒散或参苏饮等,可随证选用。

身体壮实,无汗而脉浮紧的,可用麻黄汤发汗解表。若兼有湿邪,肢体痠痛较甚,且有鼻塞声重、咳嗽等症的,可用荆防败毒散加减。体质虚弱,汗出而脉浮缓的,可用桂枝汤调和营卫。若内兼痰滞,证见咳嗽痰多,胸闷不舒,虽无汗而脉弱的,可用参苏饮加减。

二、风温表证

主证:发热,微恶风寒,头痛眩晕或伴见咳嗽,舌边尖红,苔薄白,脉浮数。

分析:本证为感受风温之邪而引起,故恶寒的症状较轻而发热比较显著。舌边尖红,脉浮数,是表热的证候。风热上扰,故头痛而兼眩晕。风温犯肺,肺气不宣,故有咳嗽的兼症。

治则:疏风泄热,辛凉解表。

方药:银翘散、桑菊饮。

以发热为主证的,用银翘散。以咳嗽为主证的,用桑菊饮。

三、暑温表证

主证:发热较高,微恶风寒,头痛身痛,微汗出或无汗,心烦口干,身重困倦,或见咳嗽,苔白腻,舌质红,脉濡数。

分析:本证多由于夏季炎热气候感受暑邪发病。暑为火邪,故发热较高,心烦口干。暑多兼湿,故身重困倦,苔白腻而脉濡数。因邪在表,故仍有微恶风寒。但暑温表证传变较快,易入气分。

方药:新加香薷饮加减。

本方为清热解暑化湿的常用方药。香薷有解表发汗利湿作用,但汗出较多时,可改用青蒿。如口渴可加西瓜皮、花粉;咳嗽加北杏仁、桔梗等。

(下转第20页)

颈无强硬，气管居中。胸、腹、腰肌无紧张，四肢脊柱无强硬及瘫痪。心尖部可闻2级收缩期杂音，肺呼吸音略粗无罗音，四肢肌张力无减弱，未引出病理性神经反射，既往无高血压病史。入院诊断：头部破伤风。

入院后，即椎管注射破伤风抗毒素6000单位，使用冬眠灵25毫克，非那根25毫克合剂肌注，日三次；内服红骨蓖麻根2钱，日一次，结合支持疗法及针刺合谷、颊车，治疗16天，阵发性咬牙消失，张口达1.5公分，吞咽顺。3月11日已可进烂饭，但面瘫恢复较慢，19日出院，在当地继续针灸治疗面瘫。

讨 论

一般认为：头部破伤风是在头、面、颈部创伤后发生不同程度的牙关紧闭，伴以单纯或合并存在的第3、4、6、7、9、11及第12对脑神经麻痹。它既没有全身性破伤风的角弓反张等症状，也不象局部破伤风那样仅有局部肌肉的痉挛。所以凡头面部创伤后发生的全身性破伤风症状或仅有头面部肌肉局部痉挛者，均不符合本定义。

我院收治的两例均有牙关紧，周围性面神经瘫痪的表现，并有阵发性咬牙，但无全身性的角弓反张，四肢强直等症状，两例创伤部位均在头面，症状表现均有吞咽及发音困难等症状，很可能是合并7、9、12等脑神经麻痹。我们认为，这两个病例是符合上述头部破伤风的概念的。

病例一曾出现过呼吸循环衰竭，可能肺部感染及中枢受毒素侵犯，加上长时期使用镇静药，是其原因之一。一般认为头部破伤风创伤接近脑中枢，毒素容易进入中枢及侵犯脑神经，要提高警惕，首先注射足量的破伤风抗毒素（以椎管内注射为佳），以中和尚未与神经组织结合的毒素，适当使用冬眠镇静药，以减少抽搐发作。当合并肺部感染等而出现呼吸道阻塞时，要果断及时进行气管切开，并须加强护理，勤吸痰，在气管内喷雾雾化可的松、菠萝蛋白酶、抗菌素，以溶解粘痰，防止感染，保持呼吸道通畅，补充营养，注意水电解质平衡。我们体会到头部破伤风虽属病情凶险，若能积极抢救，大都可治愈。以上二例头部破伤风病人病情较重，经过抢救均获痊愈，为今后提高头部破伤风的疗效打下了初步的基础。

（上接第18页）

四、湿温表证

主证：恶寒，发热不扬，头痛而重，胸膈肢倦，无汗，苔白腻，脉濡或浮缓。

分析：恶寒、发热、头痛是卫分病的主证。因兼有湿邪，湿性重着粘滞，故头痛重坠，四肢困倦。湿遏热伏，故身热不扬。湿热内阻气机，故见胸膈无汗，苔白而腻。脉濡或浮缓，为表证兼湿的脉象。

治则：透湿清热。

方药：三仁汤加减。

表证宜汗，这是常法。本证因兼湿邪阻滞，故宜以透湿为主，湿邪得化，气机流通，

自然微汗而解。临床应用时，可酌加藿香、佩兰、苏梗之类。

五、秋燥表证

主证：微恶风寒，发热，头痛无汗，咽干鼻燥，咳嗽无痰，舌红苔薄白而干，脉浮数。

分析：本证多见于暑热未清而气候干燥的秋天季节，故初起即见发热、咽干鼻燥、脉浮数等燥热症状。燥邪易于伤肺，故见咳嗽无痰。舌红、苔薄白而干，也是燥热的表现。

治则：辛凉润燥。

方药：桑杏汤。

燥邪侵犯肺卫而侧重于肺津受伤，故治法重点宜放在润燥泄热清肺。（未完待续）